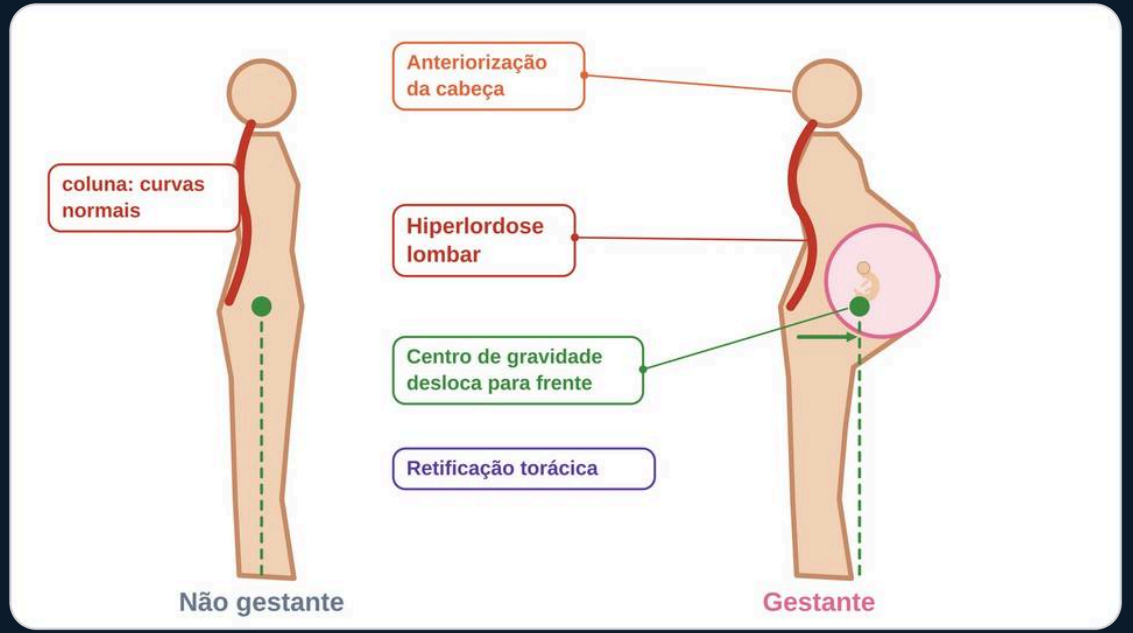
Mudanças no corpo da mulher

Aula 7 · Unidade VI

Gestação, parto e puerpério: o que muda no corpo da mãe e onde a fisioterapia atua.

2 horas



Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa
Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

ROTEIRO DE HOJE

Ao final da aula você vai saber

1. **Descrever**
   as adaptações cardiovasculares, respiratórias, posturais e musculoesqueléticas da gestação

2. **Conhecer**
   os quatro períodos do parto e o puerpério

3. **Relacionar**
   cada alteração com uma conduta de fisioterapia

VISÃO GERAL

O corpo inteiro se reorganiza

Hormônios

progesterona, estrogênio e relaxina

Mecânica

útero e bebê crescendo deslocam o centro de gravidade

Demanda

o corpo atende a dois organismos

Hoje: sistemas, postura, abdome e assoalho, parto e puerpério.

Mais sangue, mais respiração

+50%

volume plasmático

+30 a 50%

débito cardíaco

Hiperventilação

progesterona estimula o centro respiratório

Diafragma elevado

o útero empurra para cima: cansa e falta ar mais cedo

Exercício na gestação: prescrever por percepção de esforço e conforto.

ALERTA DE SEGURANÇA

Hipotensão supina

O que acontece

em decúbito dorsal o útero comprime a veia cava inferior

Consequência

cai o retorno venoso, o débito e a pressão: tontura, palidez, sudorese

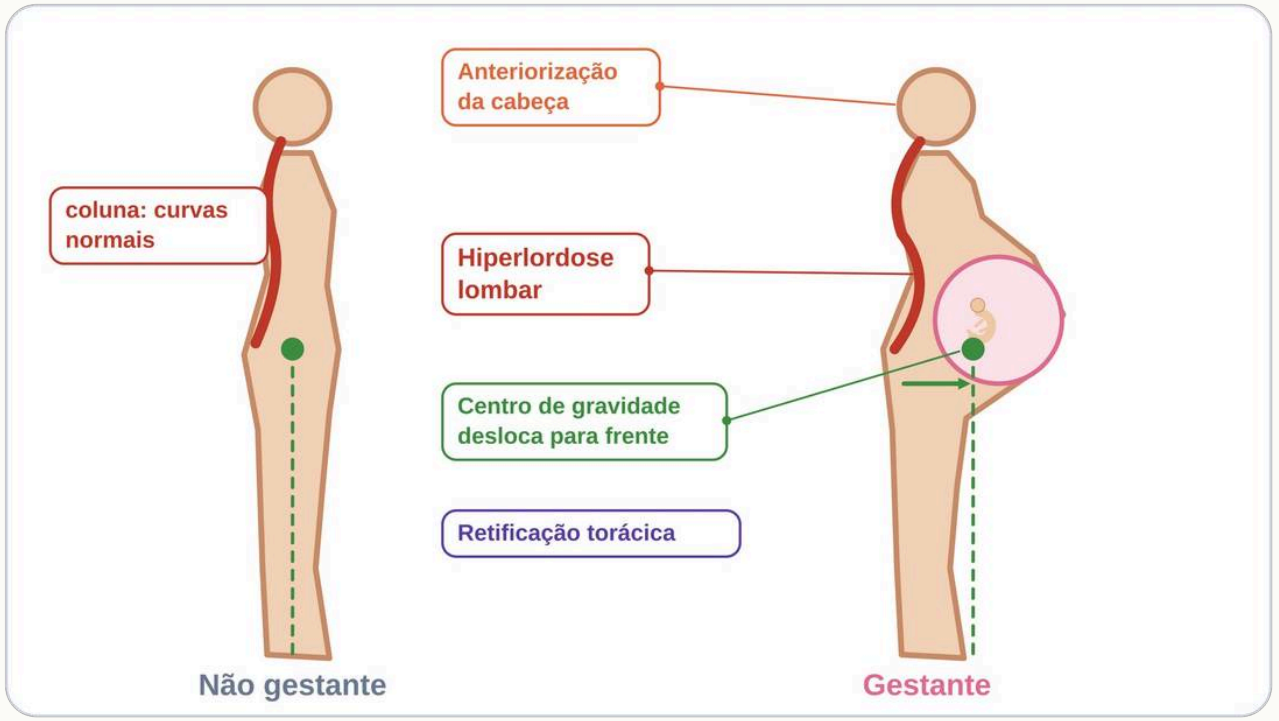
Conduta

lateralizar, de preferência para a esquerda

Em fases avançadas, evitar decúbito dorsal prolongado.

POSTURA

Centro de gravidade para frente



1. **Hiperlordose lombar**
   a lombar aumenta a curvatura para compensar

2. **Retificação torácica**
   a coluna torácica tende a se retificar

3. **Anteriorização da cabeça**
   compensação cervical

Resultado: dor lombar, a queixa mais comum da gestação.

HORMÔNIO DA VEZ

Relaxina: ótima para o parto, desafiadora para o corpo

Origem

corpo lúteo e placenta

Efeito

aumenta a frouxidão de ligamentos e tecido conjuntivo

Função biológica

preparar a pelve para o parto

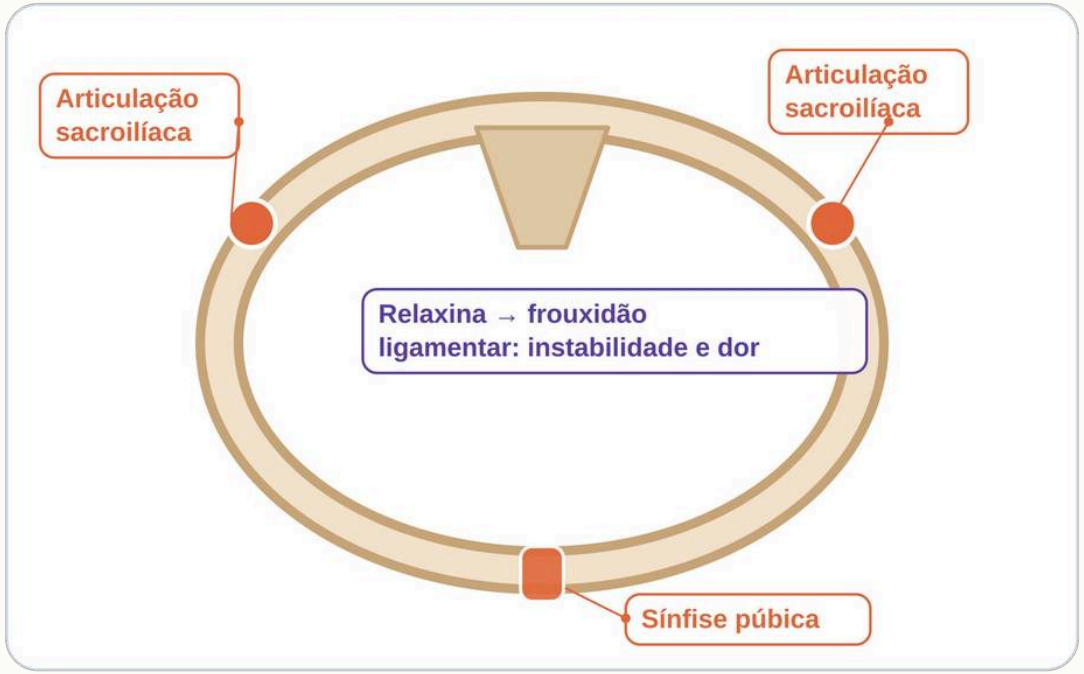
Consequência

articulações mais instáveis e mais dor

Evitar alongamentos extremos e grandes amplitudes.

PELVE

Sínfise púbica e sacroilíacas mais móveis

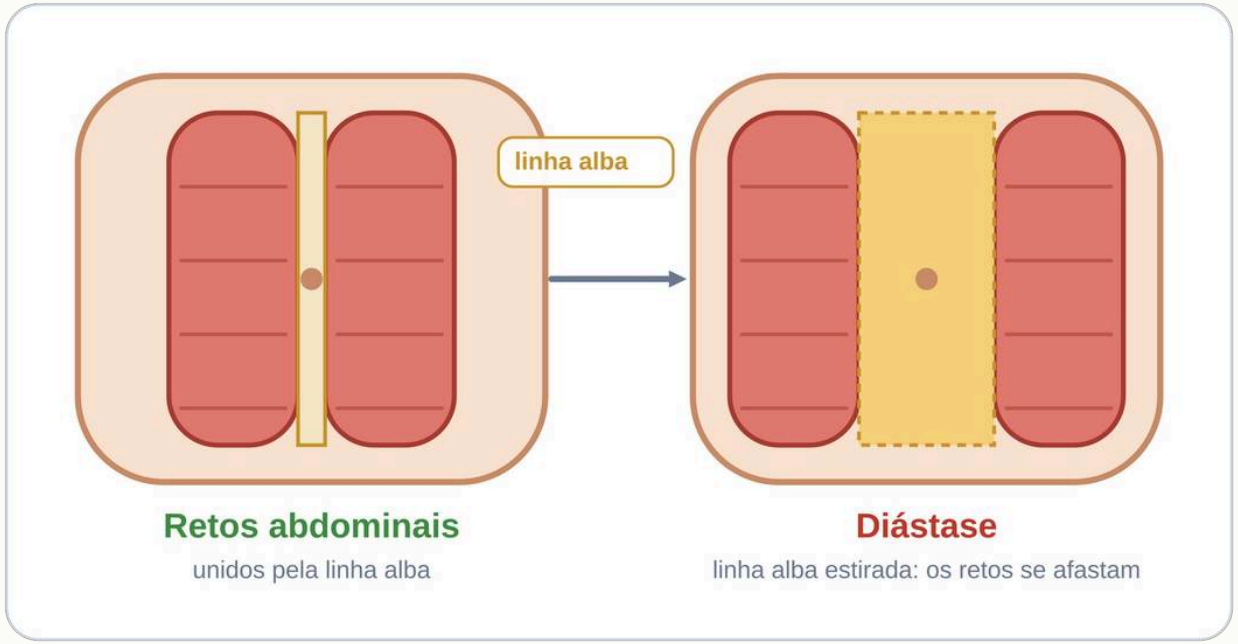


1. **Dor pélvica gestacional**
   dor púbica e sacroilíaca ao andar, virar, subir escada

2. **Conduta**
   cinta de suporte, estabilização, orientação de atividades

3. **Dica de vida diária**
   virar "em bloco", travesseiro entre os joelhos

Diástase dos retos do abdome



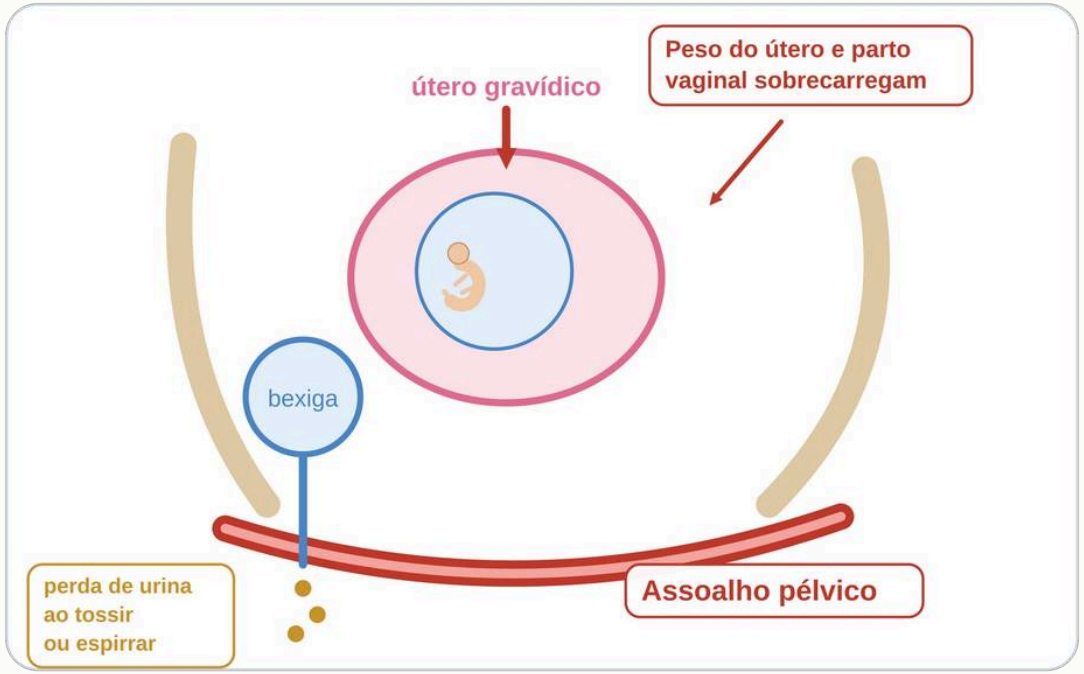
1 **O que é**
afastamento dos retos na linha alba

2 **Consequência**
menor estabilização do tronco e mais dor lombar

3 **Cuidado**
evitar abdominal tradicional; ativar transverso

Questão da apostila: diástase é o afastamento na linha alba.

A rede muscular que sustenta a pelve



1 **Sobrecarga**
peso do útero, relaxamento hormonal e parto vaginal

2 **Incontinência urinária de esforço**
escape ao tossir, espirrar, rir

3 **Tratamento**
Kegel, biofeedback e orientação de pressão abdominal

Lógica: progesterona relaxa, útero comprime

Sistema	O que acontece	Queixa comum
Digestório	progesterona reduz a motilidade	azia e constipação
Urinário	útero comprime a bexiga	polaciúria
Metabolismo	gasto energético aumentado	ganho de peso esperado
Tegumentar	pigmentação e distensão da pele	cloasma, linha nigra, estrias

A maioria das alterações de pele regride depois do parto.

Como atuamos

Educar

postura e atividades de vida diária

Exercitar

exercício adaptado, com liberação obstétrica

Tratar

dor lombar e pélvica

Preparar

assoalho pélvico

Respirar

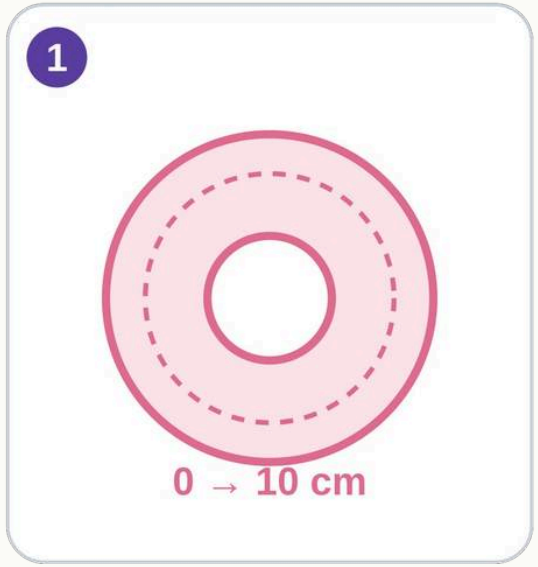
respiração e relaxamento para o parto

Trabalhar em equipe

obstetra e enfermagem

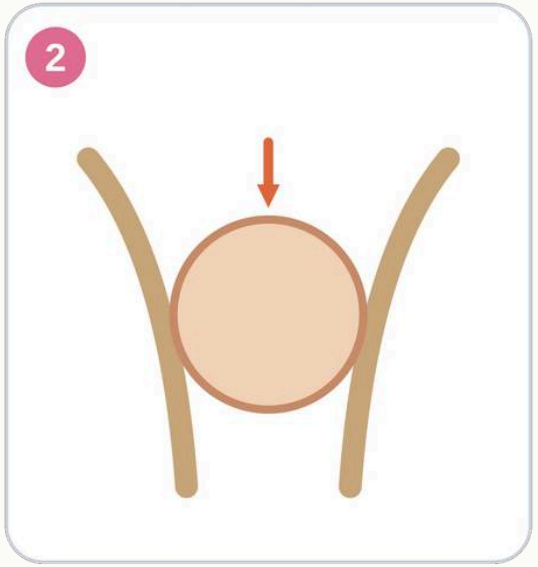
PARTO

Os quatro períodos do parto



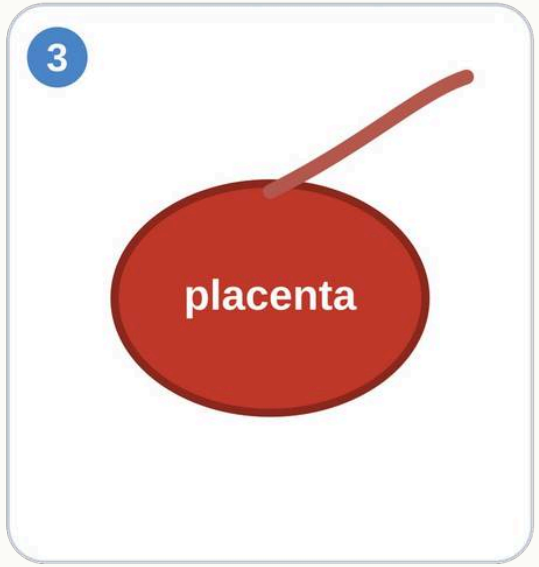
Dilatação

colo até 10 cm



Expulsão

nascimento do bebê



Dequitação

saída da placenta



4º período

1ª hora: risco de atonia

Dilatação, expulsão, dequitação e quarto período (1ª hora após a saída da placenta).

O que importa em cada período

Dilatação
colo dilata até 10 cm; fase mais longa

→

Expulsão
do colo dilatado ao nascimento

→

Dequitação
saída da placenta e membranas

→

4º período
1ª hora; risco de atonia uterina

Atonia uterina: o útero não se contrai e não fecha os vasos do sítio placentário: hemorragia.

Apoiar sem conduzir

Respiração

controle da ansiedade e da dor

Posicionamento

bola suíça, deambulação, posições verticalizadas

TENS obstétrico

estimulação elétrica de baixa intensidade na região lombar

Protagonismo

a mulher escolhe entre as opções

PUERPÉRIO

Cerca de 6 semanas de recuperação

Involução uterina

o útero volta ao tamanho e à posição

Lóquios

perda de sangue e secreção

Permanecem

diástase, fraqueza do assoalho, alterações posturais

Alertas

febre, dor intensa, sangramento excessivo, dor e edema em uma perna

REABILITAÇÃO

Reconstruir com calma

Assoalho

retorno progressivo dos exercícios, com avaliação

Diástase

reeducação do abdome, foco no transverso

Postura

ergonomia na amamentação e no carregar o bebê

Atividade física

retorno gradual após liberação médica

OFICINA EM ESTAÇÕES · 30 MINUTOS

Quatro estações, grupos em rodízio

Cada grupo passa por todas as estações e registra uma orientação para uma gestante, com justificativa anatômica ou fisiológica.

1. Estação 1: postura e dor lombar
2. Estação 2: assoalho pélvico e Kegel
3. Estação 3: diástase, identificar e proteger
4. Estação 4: trabalho de parto, respiração e posicionamento

ORIENTAÇÕES PARA A DISCUSSÃO

Uma possível resposta por estação

1. Postura

centro de gravidade e relaxina; postura, cinta, estabilização

2. Assoalho

contrair sem acionar glúteo e abdome; progredir

3. Diástase

evitar abdominal tradicional; ativar o transverso

4. Parto

respiração, posições verticalizadas, TENS adjuvante

QUIZ RELÂMPAGO

Três perguntas da apostila

1. A hiperlordose lombar na gestação resulta de:

A) Aumento da massa óssea

B) Centro de gravidade deslocado e frouxidão ligamentar pela relaxina

C) Redução do volume plasmático

D) Hipotensão supina

2. A diástase dos retos do abdome é o afastamento:

A) das costelas

B) dos retos na linha alba

C) das sacroilíacas

D) da sínfise púbica

3. Atonia uterina é a principal causa de hemorragia no:

A) Período de dilatação

B) Período de expulsão

C) Período de dequitação

D) Quarto período

RESPOSTAS

Gabarito

Questão 1: B

Centro de gravidade e relaxina explicam a hiperlordose.

Questão 2: B

Afastamento dos retos na linha alba.

Questão 3: D

Atonia uterina: hemorragia no quarto período.

Para estudar em casa (discursivas)

Por que a hiperventilação na gestação é esperada?

Por que se evita o decúbito dorsal prolongado na gestação avançada?

PARA LEVAR

Cinco ideias para guardar

1. **Hemodinâmica**
   volume plasmático +50% e débito cardíaco +30 a 50%

2. **Postura**
   centro de gravidade e relaxina explicam hiperlordose e dor lombar

3. **Diástase**
   afastamento dos retos na linha alba

4. **Assoalho pélvico**
   muito solicitado; Kegel e biofeedback tratam

5. **Parto**
   quatro períodos; o quarto é a hora da atonia

REFERÊNCIAS

Para estudar mais

- Apostila de Embriologia 2026, Curso de Fisioterapia. Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa.
- MAIA, G. D. Embriologia humana: texto básico para os cursos de ciências da saúde. São Paulo: Atheneu, 2005.
- MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
- COCHARD, L. R. Atlas de embriologia humana de Netter. Porto Alegre: Artmed, 2003.